

Fecha Última Actualización: 13-07-2022 13:49:46

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Gerardo Aníbal Riveros González
Edad : 33a 3m 27d
Dirección : Pumillahue 01359 V Andes Del Sur

Rut : 17.030.031-9
Fecha Nacto: 16/03/1989
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2211216
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9700 5126

N° Epicrisis
311193

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Recuperación (Tránsito Pabellón)

Fecha Ingreso : 05/06/2022 00:52

Días Estadía: 38

Unidad de Egreso : Medicina Básica (2do Piso)

Fecha Egreso : 13/07/2022 13:07

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Hidrocefalia aguda

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Ventriculostomía O Instalación De Derivativa Ventricular Externa O Instalación De Captor Para Medición De Pic O Punción Biopsia O Reservorio Para Administración De Medicamentos - 05/06/2022 02:00 - Francisco Javier Santorcuato Fuentes

Epidemiología

Resumen Clínico

Datos del Paciente:

Nombre : GERARDO ANIBAL RIVEROS GONZALEZ

RUT : 17030031-9

Edad : 33 años

FI CASR: 05/06/22

FI Recuperación: 05/06/22

FI UCI: 08/06/22

Antecedentes:

- Médicos: Hidrocefalia congénita (usuario de DVP), encefalomalacia fronto-parieto-temporal izquierda, hemiparesia braquiocrural derecha, epilepsia 2°.
- Quirúrgicos: Instalación DVP, último cambio hace 20 años aprox.
- Fármacos: Fenitoína.
- Alergias: Ninguna
- Hábitos: No precisados.
- Hospitalizaciones recientes: Ninguna

Anamnesis Próxima:

Paciente con antecedentes descritos, ingresa por cuadro de cefalea progresiva, fiebre y compromiso cualitativo de conciencia de aprox. 1 semana de evolución, sin respuesta a manejo sintomático. Ingresó inicialmente a HLF, donde evoluciona con caída de Glasgow hasta 7, por lo que se protege vía aérea y se traslada a CASR. Dentro del estudio, se realiza TAC de cerebro que evidencia hidrocefalia aguda, con desplazamiento de DVP, por lo que el 05/06 se retira DVP y se instala DVE. En cuanto a fiebre, se estudió con punción lumbar, no inflamatoria, con 3 células, se toman cultivos e inicia antibióticos de forma empírica. Ingresó inicialmente a Recuperación y posteriormente a UCI para continuar estudio y tratamiento.

Fecha Epicrisis : 13/07/2022 13:49

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 15:39

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 13-07-2022 13:49:46

Página 2 de 4

Diagnósticos de ingreso a UCI

- Sepsis de foco no precisado
- Sospecha de meningoencefalitis
- Hidrocefalia aguda
- Desplazamiento de DVP
- Antecedentes Hidrocefalia congénita (usuario de DVP), encefalomalacia fronto-parieto-temporal izquierda, hemiparesia braquiocrural derecha, epilepsia 2°.

Evolución en por sistemas:

Hemodinamia: Paciente actualmente sin conflicto, normocárdico, normotenso, sin necesidad de transfusión. Mantener vigilancia

Respiratorio: Paciente extubado el 13/06 sin incidentes, mantiene FiO2 ambiental sin disnea, con buen control de secreciones. Vigilancia. Antecedente de TEP subsegmentario basal derecho diagnosticado el 28/06, actualmente en tratamiento anticoagulante.

Eco Cardio 04/07: Examen dentro de límites normales, sin repercusión hemodinámica en contexto de TEP.

Infeccioso: Ingresos con sepsis de foco no precisado, con sospecha de Meningitis/Ventriculitis, se inicia ATB empírico con Aciclovir, Ceftriaxona y Metronidazol y se toman cultivos que resultan (-), incluyendo 2 PL no inflamatorias, PCR virus herpes (-) en LCR, cultivo de DVP retirada (-), sólo destaca TAC TAP con signos inflamatorios a nivel vesical, dejándose tratamiento con Meropenem/Vanco con dosis ajustadas para cobertura meníngea. El 27/06 se confirma bacteriemia por KPN KPC con fuente muy probable CVC (HC periférico (+), arrastre (+), punta (+) y HC 1/2 (+) por lo que se rota a ceftazidima-avibactam 2.5 g c/8h ev. Evolución afebril y con disminución de PPII. El 30/06 se toma HC de control que muestra S. Epidermidis a las 36 hrs que posteriormente se interpreta como contaminación por Infectología, dando pase quirúrgico para DVP. Completa 14 días de tratamiento antibiótico el 12/07/22

Neurológico: Con antecedente de hidrocefalia congénita, usuario de DVP, último cambio a los 13 - 14 años en INCa, con controles al día hasta periodo pre pandemia. Ingresos por compromiso de conciencia progresivo, secundario a desplazamiento de DVP, la cual fue retirada al ingreso y cultivada. Se instala DVE y tras resolución de eventos infecciosos se instala nueva DVP el 05/07, procedimiento sin incidentes. Antecedente de epilepsia secundaria en tratamiento con Levetiracetam, previamente con Fenitoina la cual fue suspendida por alteración de pruebas hepáticas. Sin episodios convulsivos durante la hospitalización. En seguimiento por equipo de Neurología.

El 08/07 se tiene respuesta de IC a NeuroCx quienes refiere TC de control dentro de límites esperables, sin indicación de nuevo control salvo deterioro.

Medio interno: El 10/06 destaca hipofosfemia leve que se carga, respondiendo favorablemente. El 11/06 evoluciona con Hipokalemia de 2.84 e Hipofosfemia de 0.7 realizándose nueva carga. Se mantiene vigilancia de marcadores de realimentación. Sin otros trastornos hidroelectrolíticos durante estadía, sin falla renal.

Nutricional: Ingresos en régimen cero con hidratación parenteral, el 09/06 reinicia NE con Fresubin, bien tolerado. Evaluado por fonoaudiología, inicia aporte oral el 23/06, de forma progresiva. El 29/06 se retira sonda nasogástrica por buena evolución, con aporte de régimen líquido-espeso bien tolerado. Se solicita reevaluación por equipo de fonoaudiología

Urológico: Durante el retiro de SF presenta cristalización de cuff con dos episodios de RAO por lo que se mantiene sonda. Se estudia con OC no inflamatoria, UC (-). IC a urología sugiere iniciar tamsulosina 5-7 días y realizar nueva prueba con cateterismo intermitente, iniciando el 09/07.

Rehabilitación: Paciente con alto riesgo de TVP, actualmente en anticoagulación por TEP subsegmentario. Se indica KNT motora intensiva para favorecer la movilización precoz.

Diagnósticos al alta

ITS/CVC x K. Pneumoniae BLEE KPC (+) resuelta

ATB ceftazidima-avibactam 14/14

TEP subsegmentario basal derecho sin signos de sobrecarga ventricular en anticoagulación

Fecha Epicrisis : 13/07/2022 13:49

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 13-07-2022 13:49:46

Página 3 de 4

Sd diarreico agudo resuelto
Hidrocefalia aguda por desplazamiento de DVP
DVE 05/06.
DVP 05/07.
Hidrocefalia congénita, usuario DVP
PCR SARS CoV2 (-)
Hisop Rectal Bact Prod Carba y Entero R Vanco (-) 10/06, 15/06

Diagnóstico de Egreso

Hidrocefalia Aguda -
Sepsis, no especificada - Foco Urinario Vs Meníngeo

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

En buenas condiciones, hemodinamia estable, FiO2 ambiental, sin disnea, con buen control de secreciones. En condiciones de alta con HOSDOM

Plan Post Alta

Indicaciones al alta
Reposo relativo. Mantener aislamiento físico preventivo en domicilio por 14 días por hospitalización reciente. Lavado de manos frecuente, uso de mascarilla, respetar distancia social. Evitar aglomeraciones.

Régimen liviano

HOSDOM:
Continuar con traslape a TACO
Rehabilitación kinésica
Retiro de S. Foley completado 7 días con Tamsulosina

Medicamentos
Levetiracetam 1000 mg cada 12 horas VO
Enoxaparina 40 mg c/12 hrs SC (traslape TACO)
Paracetamol 1g cada 8 horas SOS si dolor VO
Bromuro de Ipratropio 2 puff cada 8 horas por AEC INH
Risperidona 0.5mg SOS VO
Acenocumarol 4 mg según esquema (ajustar por hospitalización domiciliaria)

Controles:
Con Neurología para control de DVP y esquema antiepiléptico
En Policlínico de TACO para continuar tratamiento anticoagulante
En APS para continuar con sus controles habituales
Retiro de corchetes y control con neurocirugía 21 días posterior a cirugía (26/07)

Acudir al servicio de urgencia
Consultar en caso de dolor torácico, sensación de palpitaciones, dificultad para respirar, sensación de falta de aire, fiebre >37.8°, desorientación, o en caso de estimar necesario.

Dr. Muñoz / Dr. Claro / Dr. Lahera

Medicina Interna

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Común

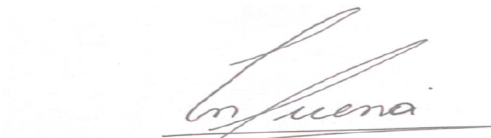
Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 13/07/2022 13:49

Página 3 de 4

Controles

INTERNO


Bec. Constanza Norambuena Orell
Becado/Residente


Tomás Lahera Frohmann
Médico Tratante (Staff)